

URGENCIAS NASOSINUSALES

N. Bilbao Garitagoitia, K. Montaña Rueda, J. Prada Pendolero.

EPISTAXIS

Introducción

Todo sangrado originado en las fosas nasales es una epistaxis, más frecuente en hombres, es fácilmente controlable pero a veces puede comprometer la vida por hemorragias intensas. Se estima que más del 90% de las epistaxis provienen del área de Kiesselbach. Aun así, la irrigación nasal se lleva a cabo por ramas de la arteria carótida interna y externa por lo que puede generar grandes sangrados posteriores. Es la urgencia más frecuente de ORL por la que acuden a urgencias, debido en gran medida a una gran vascularización de las fosas nasales, la distribución submucosa de sus vasos y la débil protección y la superficialidad de las fosas y pirámide nasales.

Causas

Es diversa su etiología: epistaxis esencial (es la más frecuente), traumática (traumatismos maxilofaciales, otros), infecciones e inflamaciones (rinitis), sequedad de la mucosa (aire seco), cuerpos extraños en fosas nasales (asociado a olor y rinorrea fétida), causas sistémicas como la HTA, alteración de la coagulación, factores hormonales como tumores hormono secretores: feocromocitoma, neoplasia naso-sinusal u otras, etc.

Locales	Sistémicas
• Traumatismos: nasales, craneales. • Cuerpo extraño (rinorrea fétida) • Infecciones: resfriado común. • Rinitis/sinusitis. • factores hormonales como tumores hormono secretores: feocromocitoma. • Tumores: hemangioma, angiofibroma juvenil.	• Hipertensión arterial. • Alteración de la coagulación por consumo de fármacos como los anticoagulantes, AINES, AAS. • Enfermedades hematológicas: von Willebrand, Bernard-Soulier, Werlhof (PTI), Rendu-Weber Osler.

Clasificación. Según su localización se clasifica en:

- **Epistaxis anterior:** el punto de sangrado se localiza en la zona anterior de las fosas nasales generalmente en el área de Kiesselbach ubicados en la parte anterior del tabique nasal o en su proximidad, es la forma más frecuente en niños y adultos, la sangre sale por la fosa nasal anterior.
- **Epistaxis posterior:** se origina en las ramas posterolaterales de la arteria esfenopalatinas y arterias etmoidales, sangran hacia la faringe por las coanas, expulsa la sangre por la boca, obligándonos a plantear un diagnóstico diferencial con la hematemesis o hemoptisis.
- **Epistaxis difusa**

Diagnóstico

El diagnóstico es clínico, basado en la presencia y expulsión de sangre por las fosas nasales (epistaxis anterior) o por la boca (epistaxis posterior), debemos de:

- Valorar causas desencadenantes y antecedente de traumatismo, cirugía previa, cuerpo extraño, antecedentes previos, etc.
- Anamnesis detallada: tratamiento habitual, antecedente de HTA, anticoagulantes, antiagregantes, enfermedades hematológicas, drogas intranasales.

Tratamiento

- **Medidas generales en urgencias.**

1. Constantes vitales y canalización de vía venosa periférica.
2. Estabilización hemodinámica si el sangrado es abundante y sospecha de hipovolemia.
3. Control de HTA si tensión alta.
4. Analítica sanguínea (si sangrado abundante o toma de anticoagulantes): hemograma, bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, alaninoamino transferasa (ALT o GPT), aspartato aminotransferasa (AST o GOT), bilirrubina, PCR. y coagulación.

- **Taponamiento anterior:**

Considera usar medidas generales de protección individual: guantes, mascarilla facial o lentes de protección y bata. Los sangrados anteriores podrán ser localizados con vasoconstrictor tópico (lidocaína 2% o adrenalina 1/1,000) y cauterizados con stick de nitrato de plata, electrocauterio o criocauterio.

- Paciente sentado con la cabeza levantada, tranquilice y explíquele el procedimiento a realizar.
- Limpiar con suero fisiológico las fosas nasales.
- Humedecer un algodón con oximetazolina o lidocaína 2% o adrenalina 1/1000 introducirlo en la fosa nasal sangrante y comprimir con los dedos por ambos lados de las alas nasales durante un tiempo mínimo de 10 a 15 minutos. Habitualmente con este procedimiento debería de parar el sangrado.
- Pida que abra la boca y observe la pared posterior de la faringe, si observa que fluye sangre a pesar de la oclusión nasal podría dar a entender que el sangrado procede de la parte posterior de la nariz: epistaxis posterior.
- El taponamiento anterior se realiza con Merocel, la gasa de borde, Rapid Rhino.
- Mantener durante 2 días si sangrado es leve excepto en los que reaparece el sangrado tras retirar el taponamiento en ese caso se retira entre 4 y 7 días (pacientes con sangrado más intenso, toma de anticoagulantes o presentan coagulopatías) y se administra cobertura antibiótica.*
- Si sangrado no se controla con taponamiento anterior se avisar a ORL.

- **Taponamiento posterior.**

Indicada cuando falla el taponamiento anterior, la epistaxis es muy posterior.

1. Previo al procedimiento considera usar medidas generales de protección: guantes, mascarilla facial o lentes de protección y bata.
2. Anestesiarse la fosa nasal sangrante con lidocaína 2% más adrenalina 1:1,000
3. Se realiza neumotaponamiento con sonda bibalonada, introducir la sonda por la fosa nasal sangrante, el **balón distal** se llena con 10ml de suero fisiológico, traccionar suavemente hasta sentir resistencia y se hincha en el cavum. El **balón proximal** se llena con 30 ml de suero fisiológico, se hincha en la fosa nasal quedando ocluida con el fin de cohibir el sangrado. El taponamiento se retira en 4 días. Se debe de administrar cobertura antibiótica.*

Si el taponamiento anterior y el posterior no detienen el sangrado se debe de avisar al ORL de guardia, para que valore el mejor tratamiento oportuno y/o otras técnicas invasivas como:

Embolización arterial (menos usada, alta efectividad, punto sangrante se localiza mediante arteriografía) o

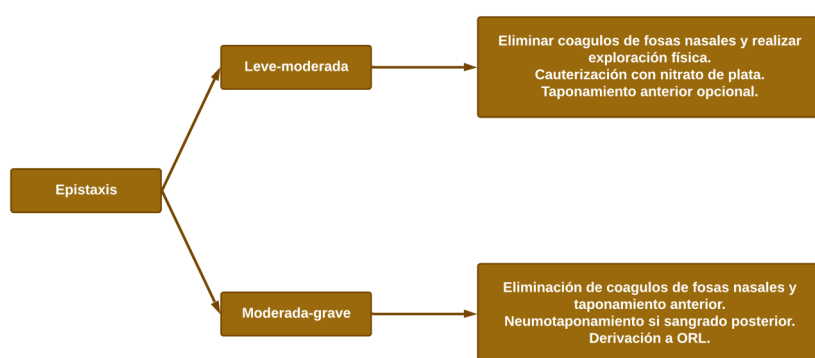
Ligaduras arteriales (según el punto sangrante puede ligarse una o varias arterias: la maxilar interna, la arteria etmoidal anterior, la arteria esfenopalatina) mediante cirugía endoscopia nasosinusal (CENS).

- **Cobertura antibiótica:**

Amoxicilina / ácido clavulánico 875/125mg cada 8h x 7 días ó

Clindamicina 300mg cada 12h x 8 días ó

Trimetoprima/sulfametoxazol 160/800mg 1 cada 12h x 7 días.



Bibliografía

- Beck, R., Sorge, M., Schneider, A., & Dietz, A. (2018). Current Approaches to Epistaxis Treatment in Primary and Secondary Care. *Deutsches Arzteblatt international*, 115(1-02), 12–22.
- Fatakia, A., Winters, R., & Amedee, R. G. (2010). Epistaxis: a common problem. *The Ochsner journal*, 10(3), 176–178.
- Smith, J., Hanson, J., Chowdhury, R., & Bungard, T. J. (2019). Community-based management of epistaxis: Who bloody knows?. *Canadian pharmacists journal : CPJ = Revue des pharmaciens du Canada : RPC*, 152(3), 164–176.
- Pinilla Urraca M. Tratamiento de la epistaxis en Atención Primaria. *Form Act Pediatr Aten Prim*. 2014;7;94-101
- Kontos J. Actualización: Epistaxis. *Evidencia-Actualización en la Práctica Ambulatoria*. 2007;10(4):115-7.
- Handbook of Otolaryngology. Head and Neck Surgery. 2011: 597-599. David Goldenberg. Bradley J. Goldstein
- Rhinology and Endoscopic Sinus Surgery. Cummings otolaryngology–head & neck surgery. 6th ed. Philadelphia: Saunders; 2015.
- Pinilla Urraca M. Tratamiento de la epistaxis en Atención Primaria. 2014, vol. 7, nº 2